

Ви лікар приймального відділення дитячої клінічної лікарні.

У 16.30 до Вас звернулася мати хлопчика 8-ти років зі скаргами на біль в животі, блювоту, спрагу, часті та великими порціями сечовипускання, головний біль, втрату ваги та сухість слизових оболонок.

Із анамнеза відомо, що вказані симптоми турбують близько місяця, дитина знаходиться на обстеженні 2-й день, стан погіршився після обіду.

В анамнезі життя: ГРВІ 3 рази на рік, прояви функціональної диспепсії, обтяжена спадковість по цукровому діабету – у дідуся.

Об'єктивно: стан дитини важкий, що обумовлено синдромом водно-електролітних порушень. Дитина в свідомості, млява. Шкіра та слизові бліді, сухі, підшкірна клітковина витончена. Запах ацетону у видихуваному повітрі. Перкуторно: ясний легеневий звук. При аускультатії – дихання везикулярне, проводиться над всією поверхнею легень, ЧД 26/хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС 100 уд/хв. Живіт м'який, болісний в пупковій ділянці. Печінка не виступає з-під краю реберної дуги. Фізіологічні відправлення – поліурія.

Показник	Дані пацієнта	Нормативні значення
Гемоглобін, г/л	147	110-140
Еритроцити, 10^{12} /л	4,97	3,7-4,9
Кольоровий показник, од	0,9	0,8-1,0
Тромбоцити, 10^9 /л	230	150 – 400
Лейкоцити, 10^9 /л	7,8	5-10
Паличкоядерні нейтрофіли, %	4	0,5-5
Сегментоядерні нейтрофіли, %	52	25-60
Лімфоцити, %	32	26-60
Еозинофіли, %	4	1-5
Моноцити, %	8	2-10
ШОЕ, мм/год	7	4-12

Рівень глюкози при надходженні – 16,6 ммоль/л

Глікемічний профіль

дата	9.00	13.00	17.00	22.00
1-й день (ммоль/л)	8.6	15.2	10.5	10.8

Глюкозурічний профіль

Дата/час	6.00-13.00	13.00-18.00	18.00-22.00	22.00-6.00
Відносна щільність сечі	1038 (n 1025)	1030	1025	1021
Ацетон	1+	3+	2+	1+
Глюкоза сечі, mmol/l	-	1	0.5	0.5

Алгоритм виконання	Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації.	

1.1	Встановити контакт з пацієнтом та батьками/опікунами (привітатись, представитись, позначити свою роль). Коректне розташування лікар-пацієнт	Сказати Доброго дня. Я лікар педіатр.
1.2	Отримання інформаційної згоди на проведення клінічного обстеження дитини	Сказати Чи даєте Ви свою згоду на проведення клінічного обстеження Вашої дитини (Будемо вважати що згода отримана)
2.Збір скарг та анамнезу		
2.1	Скарги пацієнта (зі слів батьків/опікунів)	Сказати: Скільки років дитині? Очікувана відповідь: 8 років Сказати: Які скарги у дитини? Очікувана відповідь: Скарги на біль в животі, блювоту, спрагу, часті та великими порціями сечовипускання, головний біль, втрату ваги та сухість слизових оболонок
2.2	Анамнез захворювання	Хворіє.близько місяця, дитина знаходиться на обстеженні 2-й день, стан погіршився після обіду
2.3	Анамнез життя	На які захворювання дитина хворіла? Алергія? Травми/операції? Щеплення? Спадковість?
3.Об'єктивне обстеження		
3.1	Обробити руки на гігієнічному рівні та вдягнути захисну маску і рукавички.	Виконати/сказати Будемо вважати, що руки оброблені
3.2	Оцінити загальний стан дитини, стан ЦНС, шкіри та слизових оболонок,	Сказати:стан дитини важкий, що обумовлено синдромом водно-електролітних порушень та кетоацидозу. Дитина в свідомості, млява.Шкіра та слизові бліді, сухі, підшкірна клітковина витончена. Запах ацетону у видихуваному повітрі.
3.2	Обстеження дихальної, серцево-судинної системи та провести пальпацію живота	Сказати:Перкуторно: ясний легеневий звук. При аускультації – дихання проводиться над всією поверхнею легень, везікулярне, ЧД 26/хв. Межі відносної серцевої тупості не розширені. Тони серця ясні, ритмічні, ЧСС 110 уд/хв. Живіт м'який, болісний в пупковій ділянці. Печінка не виступає з під краю реберної дуги. Фізіологічні відправлення - поліурія.

4.Діагностика		
4.1	Визначити результат клінічного аналізу крові	Невелике підвищення гемоглобіну та еритроцитів за рахунок зневоднення.
4.2	Визначити результати рівня цукру в крові, глікемічного та глюкозуричного профілей	гіперглікемія, глюкозурія, кетонурія, підвищення відносної щільності сечі
4.3	Визначити провідний синдром	синдром водно-електролітних порушень та кетоацидозу.
4.4	Встановити клінічний діагноз	ЦД, 1 тип, маніфестація, фаза декомпенсації. Діабетичний кетоацидоз.
5.Визначення тактики ведення та лікування		
5	Призначити подальшу тактику ведення пацієнта	Сказати:госпіталізація в стаціонар у відділення інтенсивної терапії або в ендокринологічне відділення, призначення інсулінотерапії, корекція водно-електролітних порушень. Венозний доступ, фіз розчин, інсулін короткої дії.
6.Профілактика та пропаганда здорового способу життя		
6	Рекомендувати профілактичні заходи	Сказати: раціональне харчування, підрахунок хлібних одиниць, ЛФК, загартовування, санація вогнищ хронічної інфекції.
7. Інше (в т.ч. легальні та етичні аспекти)		
7	Інформування пацієнтки про можливі ризики та етичні аспекти	Сказати:Ви повинні знати про можливі ускладнення ЦД – коми, діабетична нефропатія, полінейропатія, катаракта,діаб стопа.